

# Ansiolíticos

Dr. Andréé Salvatierra

# Ansiedad



- ❑ Latín → anxius («preocupado»)
- ❑ griego antiguo → lytikós («relajante»)

Ansiolíticos = Calmar la inquietud

# Consideraciones

- ☐ No es necesariamente es una enfermedad a erradicar, se considera un signo de alarma que puede poner en marcha mecanismos adaptativos, tanto de tipo reactivo
- ☐ Es normal bajo circunstancias de amenaza y es considerada como parte de la reacción de “lucha o huida” (evolutiva – supervivencia)
- ☐ La ansiedad no se “cura” pero lo que sí es factible ayudar al paciente a manejar mejor su ansiedad, la intensidad de la misma, su duración, su adaptación y modulación.
- ☐ Una característica central de todos los trastornos de ansiedad es que los pacientes se quejan de síntomas físicos.

# Espectros

Los trastornos de ansiedad por su subtipo diagnóstico:

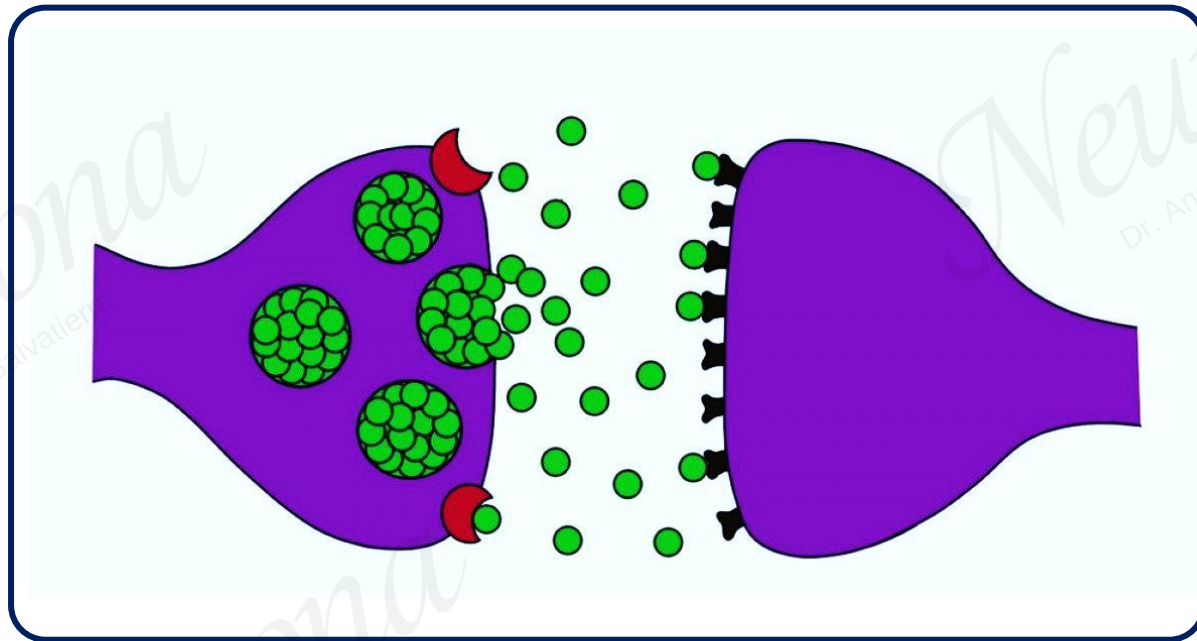
- Trastorno obsesivo-compulsivo.
- Crisis de angustia (inesperada)
- Fobia social.
- Trastorno de ansiedad generalizada (continua)
- Trastorno por estrés postraumático (episódica)
- Ansiedad debida a enfermedad médica.
- Trastorno de ansiedad inducido por sustancias.

# Etiotopatogenia

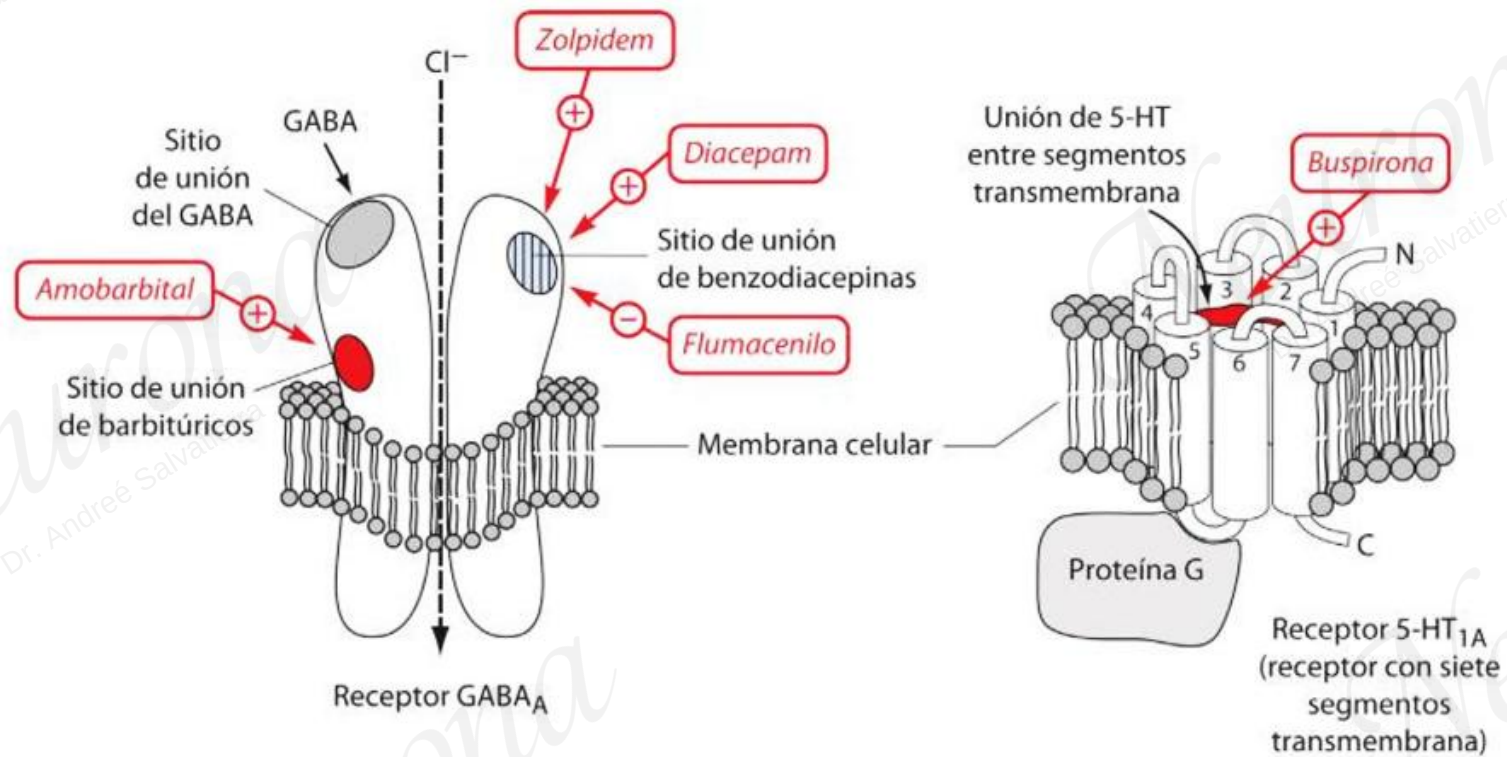
La amígdala tiene importantes conexiones que permiten integrar la información sensorial y la cognitiva para poder determinar cuándo debemos iniciar una respuesta de miedo.

- Existen conexiones recíprocas que la amígdala comparte con áreas del córtex prefrontal que regulan las emociones.
- Las respuestas motoras (lucha, huida, quedarse congelado), están reguladas por conexiones entre la amígdala y sustancia gris periacueductal del troncoencefálico.
- Las reacciones endocrinas que acompañan al miedo pueden explicarse por conexiones de la amígdala con el hipotálamo, que causan cambios en el eje hipotálamo-hipófiso-adrenal, alterando los niveles de cortisol.
- Finalmente, la ansiedad puede verse incrementada por memorias traumáticas almacenadas en el hipocampo

Cada conexión utiliza neurotransmisores específicos (GABA, serotonina, noradrenalina) cuyo desequilibrio puede explicar la aparición de síntomas, y sobre los cuales ejercen sus efectos los fármacos ansiolíticos que se utilizan actualmente como tratamiento.



Los fármacos ansiolíticos e hipnóticos importantes actúan sobre receptores  $\text{GABA}_A$  o  $5\text{-HT}_{1A}$



# **Ansiolíticos que actúan en GABA**



# Barbitúricos

Sustituidos por las Benzodiazepinas; fueron usado en los tratamientos iniciales de la ansiedad, pero su actividad ansiolítica es escasa y se encuentra ligada directamente a su actividad sedante. Además, presentan *problemas de dependencia y abstinencia*, sumado a un bajo perfil de seguridad (> con alcohol)

Su acción farmacológica fundamental es la depresión no selectiva del SNC, que según dosis puede ir desde la sedación, general, coma respiratorio y muerte, por parálisis del centro respiratorio (bulbo raquídeo)



Los barbitúricos se unen a un sitio específico en los canales iónicos sensibles al ácido gamma-aminobutírico (GABA) encontrados en el SNC, donde permiten la entrada de cloro a las membranas celulares y, subsecuentemente, hiperpolarizan la neurona postsináptica.

# Clasificación de barbitúricos

**Acción ultra corta**

**<3h**

Metohexital  
Tiopental

**Acción corta**

**2-3h**

Ciclobarbitál  
Pentobarbital  
Secobarbital

**Acción media**

**3-6h**

Amobarbital  
Aprobarbital  
Butobarbital

**Acción prolongada**

**6-12h**

Barbital.  
Fenobarbital.

# Precauciones



- ☐ Los barbitúricos se encuentran dentro de los psicofármacos más adictivos; cuando se toman con un uso recreativo es para obtener una sensación de euforia y relajación, aunque su uso es ilegal sin prescripción y supervisión médica.
- ☐ Su supresión brusca pone en peligro la vida si no hay tratamiento médico adecuado
- ☐ La combinación de barbitúricos con otras drogas es muy peligrosa, especialmente cuando se combinan con otros depresores del SNC (alcohol)

## Meprobamato

Tiene efecto ansiolítico e hipnótico. Actualmente su utilización había quedado limitada al tratamiento del síndrome de abstinencia alcohólica, hasta su retirada reciente del mercado.

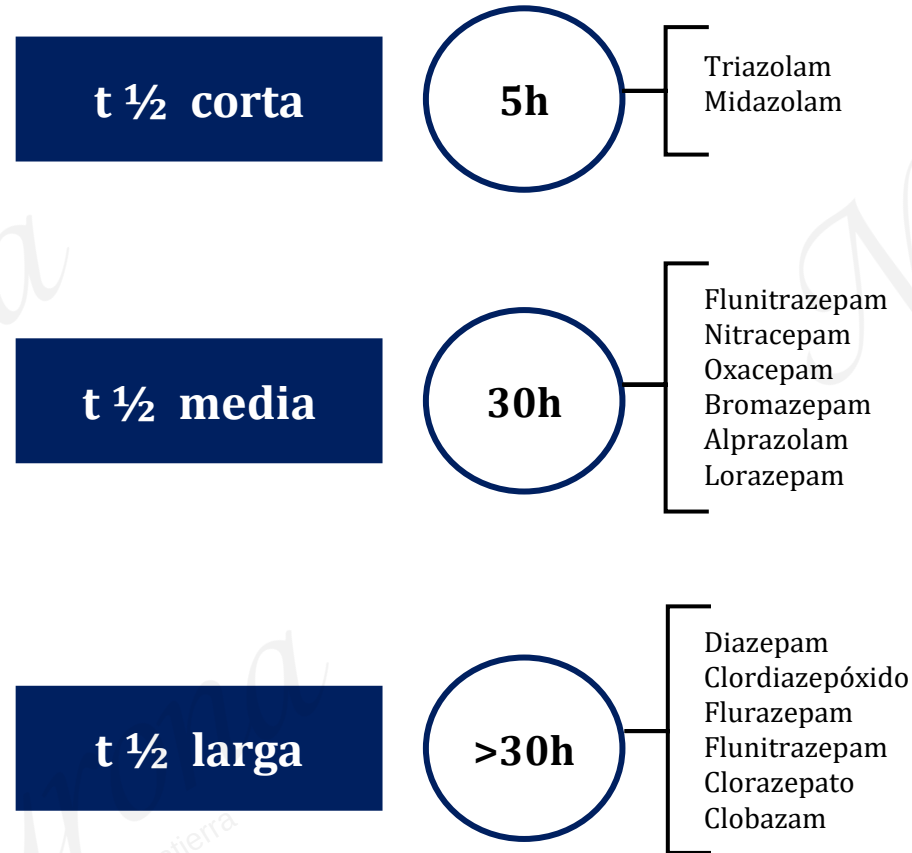
Además, produce farmacodependencia e induce el metabolismo de otros fármacos. También puede provocar depresión completa, coma y muerte.

# Benzodiacepinas

Ansiolítico más conocido; solo deben prescribirse para el tratamiento de un trastorno intenso, que limita la actividad el paciente o lo somete a una situación de estrés significativo



# Clasificación de benzodiazepinas



$t_{1/2}$  (vida media)  
tiempo que pasa hasta que la  
concentración plasmática disminuye a la  
mitad del valor inicial después de 1 dosis

### t ½ corta

#### Ventajas

- No se acumulan en sangre
- Menor somnolencia diurna

#### Desventajas

- Mayor número de dosis diarias
- Efecto rebote
- Síndrome de retirada

### t ½ larga

#### Ventajas

- Una sola dosis única.
- Menor variación plasmáticas del fármaco.
- Evita el efecto rebote.

#### Desventajas

- Riesgo de acumulación (en ancianos)
- Sedación diurna



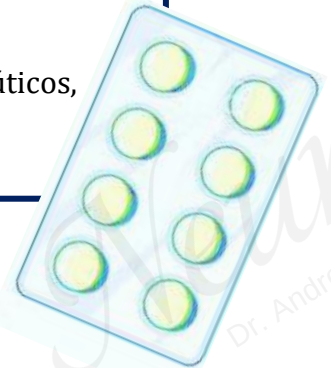
# Benzodiacepinas

| P.A                    | T 1/2                      | Indicación                                             |
|------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Clordiacepóxido</b> | Larga<br>Metabolito activo | Ansiolítico                                            |
| <b>Clorazepato</b>     | Larga<br>Metabolito activo | Ansiolítico<br>Anticonvulsivante                       |
| <b>Diazepam</b>        | Larga<br>Metabolito activo | Ansiolítico<br>Anticonvulsivante<br>Relajante muscular |
| Halazepam              | Larga                      | Ansiolítico                                            |
| Ketazolam              | Larga<br>Metabolito activo | Ansiolítico                                            |
| <b>Flurazepam</b>      | Larga                      | Hipnótico                                              |
| Quazepam               | Larga                      | Hipnótico                                              |
| Pinazepam              | Larga                      | Ansiolítico                                            |
| <b>Alprazolam</b>      | Intermedia                 | Ansiolítico                                            |
| Bromazepam             | Intermedia                 | Ansiolítico                                            |

| P.A                  | T 1/2              | Indicación                       |
|----------------------|--------------------|----------------------------------|
| <b>Clonazepam</b>    | Intermedia         | Ansiolítico<br>Anticonvulsivante |
| <b>Flunitrazepam</b> | Intermedia         | Hipnótico                        |
| Clobazam             | Intermedia         | Ansiolítico<br>Anticonvulsivante |
| <b>Lorazepam</b>     | Intermedia         | Ansiolítico<br>Anticonvulsivante |
| Lormetazepam         | Intermedia - corta | Hipnótico                        |
| Loprazolam           | Intermedia - corta | Hipnótico                        |
| <b>Oxacepam</b>      | Intermedia - corta | Ansiolítico                      |
| <b>Midazolam</b>     | Corta              | Hipnótico                        |
| Bentazepam           | Corta              | Ansiolítico                      |
| Brotizolam           | Corta              | Hipnótico                        |
| Clotiazepam          | Intermedia - corta | Ansiolítico                      |
| <b>Triazolam</b>     | Corta              | Hipnótico                        |
| <b>Flumazenil**</b>  | Corta (1 h)        | Antídoto                         |

# Consideraciones

- ❑ La absorción de la mayoría de las benzodiacepinas, se absorben adecuadamente luego de su administración oral, especialmente cuando el estómago se encuentra vacío; con el estómago lleno la absorción se retrasa, aunque la tasa de absorción total no disminuye.
- ❑ **Agentes que potencian el efecto** de las benzodiacepinas: alcohol, antiepilépticos, antipsicóticos, antidepresivos, anestésicos, anticonceptivos orales, protector gástrico (omeprazol), antibióticos (eritromicina).
- ❑ **Agentes que disminuyen el efecto** de las benzodiacepinas: Antiácidos, barbitúricos, cafeína, antibiótico (rifampicina) y antiepiléptico (fenitoína)



# Utilidades

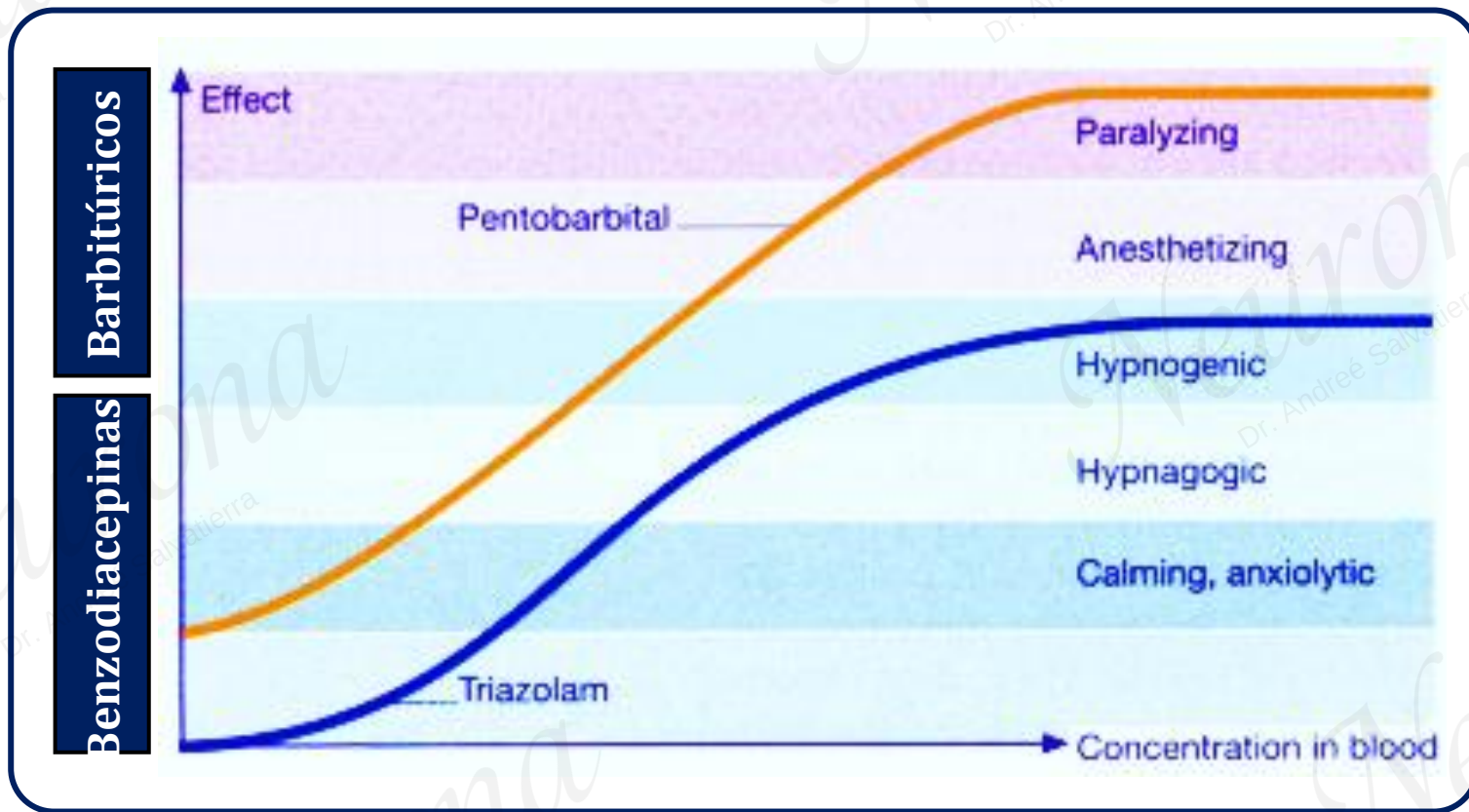
- ☐ Acción ansiolítica (*aliviar estados de tensión, agitación, inquietud y estrés*).
- ☐ Acción miorrelajante (*aliviar espasticidad o tensión muscular*) - diazepam
- ☐ Efecto amnésico (*anestesia preoperatoria*) - midazolam, clotiazepam
- ☐ Acción hipnótico/ sedante
- ☐ Efecto anticonvulsionante (*asociado a antiepiléptico*) - clozabam, clonazepam, diazepam
- ☐ Tratamiento del síndrome de abstinencia en alcoholismo (*siempre que el paciente haya dejado de beber de facto*) - *agentes de detoxificación: diazepam y clordiazepoxido/ lorazepam- oxacepam (más usado en sistemas de abstinencia severos y geriátricos)*

# Precauciones

Las benzodiacepinas en niños solo se recomiendan en casos extremos de problemática ansiosa. En tratamiento de corta duración se emplea lorazepam o alprazolam\*; es preferible tratarlos con ISRS (mejor tolerados)

En cualquier caso, la retirada del fármaco siempre se debe hacer de forma gradual, para evitar el síndrome de suspensión de las benzodiacepinas





**Flumazenil** (antagonista) = Puede bloquear las acciones de las BDZ y revertir sus efectos (ejemplo: sobredosis)

**Sedante**

Disminuye la actividad, modera la  
excitación y tranquiliza

**Hipnótico**

Produce somnolencia, facilita el  
inicio del estado de sueño

# Efectos secundarios



- Sedación y somnolencia
- Confusión
- Depresión de centros respiratorios
- Deterior funciones mentales (atención, tiempo de reacción, memoria)
- Incoordinación motora ligera
- Tolerancia y dependencia

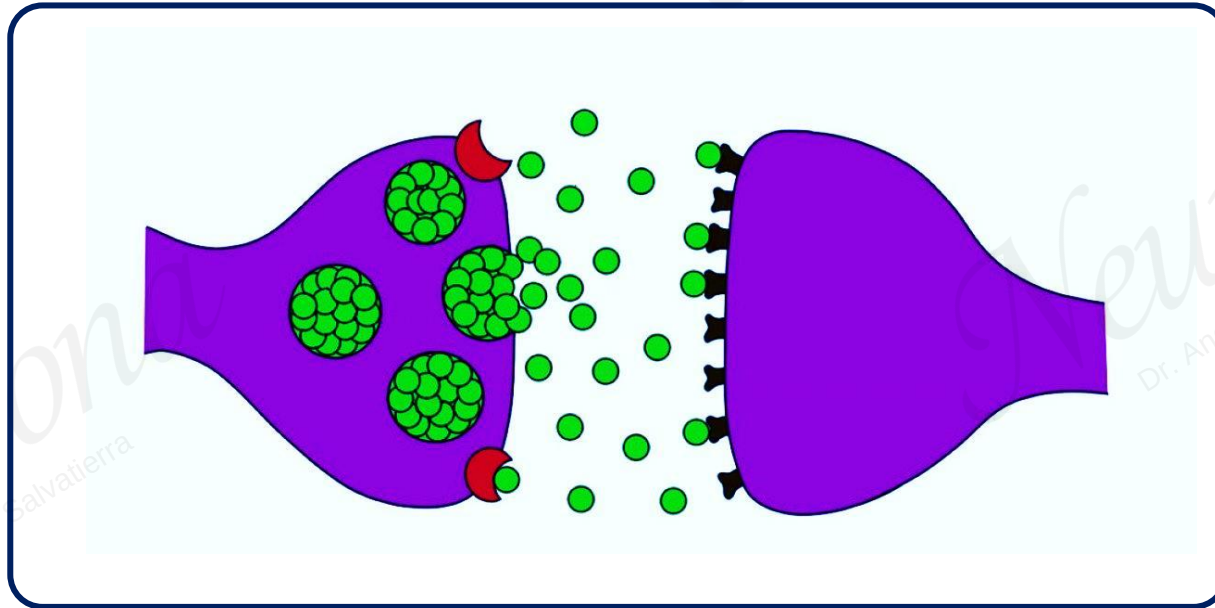


# **Ansiolíticos que actúan en 5-HT**

# Consideraciones

- ☐ Existe una aproximación simplista respecto a la relación de 5 HT entre la sintomatología ansiosa, mientras que su deficiencia explicaría el espectro depresivo.
- ☐ Sin embargo, en la práctica clínica se presencia lo contrario; al aumentar los niveles de 5 HT resulta beneficiosa para la ansiedad. Por lo cual, no es de extrañar que varios agentes antidepresivos hayan demostrado ser eficaces para el tratamiento de los trastornos de ansiedad





Actualmente, la investigación se centra fundamentalmente en los receptores de serotonina 5 HT1A,  
Los fármacos con afinidad por los receptores 5-HT1A como la bupropiona, gepirona, ipsapirona

# Buspirona

## Ventajas

- No interacciona con alcohol, otras benzodiacepinas y agentes sedantes.
- Ausencia de dependencia farmacológica.
- Facilidad de uso en pacientes con historia de abuso, drogas o alcohol.
- En ancianos, por su buena tolerancia.
- En depresiones resistentes como potenciador.
- Revierte efectos secundarios sexuales causados por antidepresivos ISRS.

## Desventajas

- Retardo en el inicio de su acción.

# **Ansiolíticos que actúan en NA**

# Consideraciones

- ❑ El output noradrenérgico excesivo desde el locus coeruleus no sólo puede dar lugar a numerosas manifestaciones periféricas de sobreactivación autónoma, también **provoca numerosos síntomas de ansiedad y miedo**, como pesadillas y estados de hiperexcitación,
- ❑ Se cree que estos síntomas de ansiedad podrían deberse a la **estimulación noradrenérgica excesiva** sobre los receptores postsinápticos  $\alpha 1$  y  $\beta 1$  adrenérgicos de la amígdala o de la corteza prefrontal.





Acciones ansiolíticas especialmente para bloquear los aspectos noradrenérgicos (taquicardia, sudoración, temblor) pero menos potente para bloquear los aspectos emocionales y subjetivos de la ansiedad

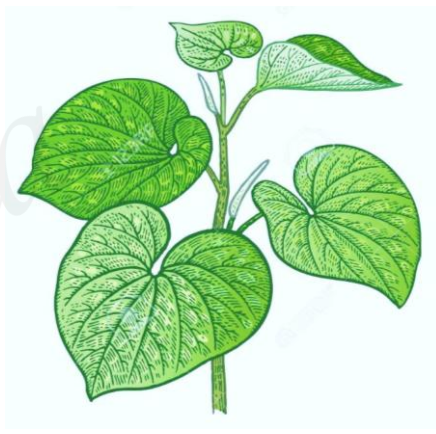
# Tratamientos alternativos

(Para episodios leves y específicos)

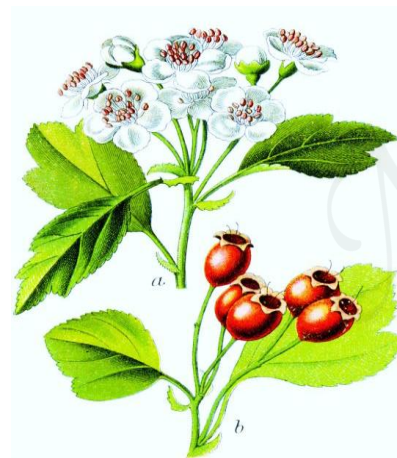




**Lavanda**  
(ansiolítico)



**Kava**  
(ansiolítico, sedante)



**Espino blanco**  
(ansiolítico)



**Pasiflora**  
(sedante)

*Dr. Andréé Salvatierra*



**Valeriana**  
(hipnótico, sedante,  
ansiolítico)



**Melisa**  
(hipnótico)



**Tilo**  
(hipnótico)



**Azahar**  
(hipnótico, sedante)

*Dr. Andree Salvatierra*

# Uso de ansiolíticos para otros trastornos

# Trastorno obsesivo compulsivo

Síndrome caracterizado por obsesiones y compulsiones («rituales»), **intrusivas e inadecuadas** que interfieren de forma significativa en las esferas del paciente, produciendo una marcada ansiedad y malestar

Relacionada con **disfunciones de serotonina y excesos de dopamina** (aún en investigación cual es predominante)

## Tratamiento de 1ª elección → ISRS

- Dosis mayores que en depresión
- Altos índices de recaída
- Inicio del efecto terapéutico retardado (< 12 semanas)

Fluoxetina  
Fluvoxamina  
Sertralina  
Citalopram  
Paroxetina

## Tratamiento con tricíclicos

Clomipramina

# Tratamiento coadyuvante

- Estrategias de potenciación serotoninérgica
- Litio (potenciador del efecto)
- Combinación con BDZ
- Adición de antipsicóticos (bloquean receptores DA)



# Ataques de pánico

*Repetidos episodios de terror inesperados, que se acompañan de manifestación físicas (autónomas) y pensamientos de desgracia.*

- ❑ Presencia de un exceso de Norepinefrina
- ❑ Desregulación del sistema noradrenérgico, con alteración en la sensibilidad de las neuronas noradrenérgicas y sus receptores.
- ❑ Hipersensibilidad a los agonistas alfa 2

## Tratamiento de 1º elección → ISRS

- Dosis mayores que en depresión
- Altos índices de recaída
- Inicio del efecto terapéutico retardado (< 12 semanas)

Fluoxetina  
Fluvoxamina  
Sertralina  
Citalopram  
Paroxetina

## Tratamiento con AD recientes

Venlafaxina  
Mirtazapina  
Reboxetina

## Tratamiento con BDZ

Uso exclusivo en momentos puntuales donde se busque un alivio rápido,

# Trastornos fóbicos

## Tratamiento de 1ª elección → ISRS

- Dosis mayores que en depresión
- Altos índices de recaída
- Inicio del efecto terapéutico retardado (< 12 semanas)

Paroxetina  
Fluvoxamina  
Sertralina  
Citalopram

## Tratamiento con AD recientes

Venlafexina

## Tratamiento con IMAO

Fenelcina  
Tranilcipromina

## Tratamiento con BZD

Clonazepam  
Bromazepam

## Tratamiento con betabloqueantes

Propanolol  
Metoprolol  
Carvedilol

# TEPT

Ansiedad ligada a un evento traumático (recuerdos)

**Tratamiento de 1º elección → ISRS**

Fluoxetina  
Fluvoxamina  
Sertralina  
Paroxetina

**Tratamiento con AD recientes**

Venfalexina

**Tratamiento con IMAO**

Fenelcina  
Tranicilpromina

**Tratamiento con betabloqueantes**

**No se recomiendan BZD (comorbilidad con abuso de alcohol)**